

Fecha Última Actualización: 12-01-2026 13:04:25

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Carlos Alberto Contreras Peroyenowski **Rut** : 13.297.746-1 **N° Archivo** : 9909601
Edad : 48a 3m 20d **Fecha Nacto**: 23/09/1977 **Sexo** : Masculino
Dirección : Diagonal Sur Oriente 0327 **Comuna** : La Granja **Teléfono** : 912345678

N° Epicrisis
468503

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto **Fecha Ingreso** : 02/01/2026 18:40 **Días Estadía**: 10
Unidad de Egreso : Utim **Fecha Egreso** : 12/01/2026 13:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Compromiso de conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Fecha Ingreso CASR: 02/01/2026
Fecha Ingreso UCI: 03/01/2026
Fecha Ingreso UTIM: 09/01/2026

Antecedentes:

- Mórbidos: DM2 NIR, PPVI en TARV (Dg 2011, inicia TARV en 2022, en controles en Hospital Clínico SBA, controles regulares con buena adherencia, (08/07/25) con CD4 1605 (47%) y CV 22 copias)
- Quirúrgicos: Colectomía
- Fármacos: TARV con Triumeq (Abacavir/Lamivudina/Dolutegravir)
- Alergias: No conocidas
- Hábitos: TBQ (-), OH (-), Drogas (-)
- Hospitalizaciones recientes: (-)
- Social: Autovalente para todas las actividades

Motivo de Consulta: Compromiso de conciencia

Historia de ingreso:

Paciente con antecedentes descritos, consulta en servicio de urgencia (SU) el día 02/01/26 traído por ambulancia, por compromiso de conciencia cuali-cuantitativo en domicilio, asociado a taquicardia, taquipnea y HGT HI. Niega golpes o caída a nivel, u otros síntomas asociados
Ingresa al SU hipertenso (161/97 mmHg), taquicárdico (105 lpm), afebril, saturando 98% ambiental, HGT HI. Al examen físico destaca en sopor medio, desorientado, moviliza 4 extremidades, con mucosas secas y restos alimentarios, lesión descamativa oral, a nivel cardiopulmonar RR2TSS, MP (+) sin ruidos agregados y mala mecánica ventilatoria
EKG con taquicardia sinusal y onda T negativa en pared inferior

Lab (02/01/26) con AL 22, Crea 2.4, BUN 54, Gluc 893, Lipasa 2022, PCR 211, ELP 124/5.2/87, GSV: pH 7.11/11.9/3.7 (AG 38, Osm 317), GB 21990, P 8.1, BT/BD 0.4/0.2, FA 169, GGT 136.

TC Tórax, Abdomen y Pelvis (03/01/26): Focos de relleno alveolar en LID y LII asociado a secreciones endobronquiales de

Fecha Epicrisis : 12/01/2026 13:04

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 12-01-2026 13:04:25

Página 2 de 4

probable carácter aspirativo. Signos de DHC inicial, leve a moderada esteatosis hepática difusa. Aumento de densidad de eje adiposo peripancreático, posible pancreatitis aguda en evolución

TC de Cerebro (03/01/26): Sin informe formal, calcificaciones periventriculares, impresiona sin hallazgos agudos.

En SU en contexto de hiperglicemia se maneja con volemicización con SF y BIC de Insulina, pese a lo cual, persiste sopor y mala mecánica ventilatoria, por lo que, se decide inicio de ventilación mecánica invasiva (VMI) y se traslada a UPC para continuar estudio y manejo.

DAGNOSTICOS INGRESO UPC:

1. Crisis hiperglicémica SHH/CAD severa:

- Compromiso de conciencia secundario
- Glicemia 893, Acidosis metabólica Anion GAP 38, Osm 317
- IOT (03/01/26)

2. Sepsis de foco abdominal y respiratorio:

- Pancreatitis aguda, etiología no precisada
- NAC Obs aspirativa

3. AKI KDIGO II multifactorial:

- Prerenal por crisis hiperglicémica, renal por sepsis
- Hiperkalemia e hiperfosfemia

4. Debut imagenológico de DHC

Antecedentes: DM2 NIR, PPVI en TARV (Dg 2011, inicia TARV en 2022, en controles en Hospital Clínico SBA, controles regulares con buena adherencia, (08/07/25) con CD4 1605 (47%) y CV 22 copias)

EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN EN UCI Y UTIM

Hemodinamia: Ingres a con shock distributivo e hipovolémico por cetoacidosis diabética (CAD) severa, descompensada por pancreatitis y sepsis. Requiere drogas vasoactivas en dosis intermedias, suspendidas el día 05/01/26. Evolucionando hemodinamicamente estable, con tendencia a la hipertensión se inician vasodilatadores orales, con buen control de presión arterial. Actualmente sin conflicto.

Ventilatorio: Ingres a con insuficiencia respiratoria aguda, NAC aspirativa y compromiso de conciencia en contexto de CAD, con requerimiento de VMI del día 03/01/26 al 07/01/26, con salida a NRC, con weaning consolidado, actualmente sin requerimiento de O2 suplementario, sin conflicto.

Metabólico: Antecedentes de DM2 NIR, con mal control crónico (HbA1c 13.5%), ingresa con CAD severa (glicemia en 893, PH 7.1, OSM 317, AG 38, cuerpos cetónicos en orina positivos) y compromiso de conciencia. Recibe manejo con volemicización y BIC de insulina, con criterios de resolución precoz. En seguimiento con equipo de diabetes, en ajuste de NPH, actualmente con NPH 36 U am y 36 U pm, con mejor control metabólico.

Como descompensante impresiona pancreatitis aguda, de etiología no clara (Colecistectomizado, pero con leve alteración colestásica de pruebas hepáticas e hipertrigliceridemia en 355) y NAC.

Infeccioso: Ingres a con IRA, TC con signos de neumonía aspirativa, del estudio microbiológico destaca CAET (+) 03/01/26 para SAMS y S agalactiae grupo B, HC I y II 04/01 (-), UC (-) y nuevo CAET (06/01) con SAMS. Se maneja por 7 días con ampicilina/ac. Sulbactam, con buena respuesta clínica y disminución de parámetros inflamatorios, sin conflicto actual.

Por antecedente de PPVI con buena adherencia a tratamiento, se mantiene con TARV. En plan continuar manejo y controles habituales.

Nefrológico/Medio Interno: Ingres a con falla renal aguda KDIGO II, multifactorial en contexto de sepsis y crisis hiperglicémicas. Con evolución favorable tras reanimación y volemicización, sin urgencia dialítica. Actualmente con función renal normal, sin alteración hidroelectrolítica. Sin conflicto actual.

Hepático: TC con signos de esteatosis hepática difusa. Con HbA1c 13.5%, VHB/VHC NR, impresiona de causa metabólica. En plan de continuar seguimiento en ambulatorio.

Neurológico: Al ingreso con compromiso de conciencia en contexto de CAD, TC de cerebro sin hallazgos. Actualmente vigil,

Fecha Epicrisis : 12/01/2026 13:04

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 12-01-2026 13:04:25

Página 3 de 4

orientado en tiempo y espacio, sin focalidad neurológica ni conflicto actual.

Rehabilitación: Durante estadía en UCI y extubación recibe evaluación multidisciplinaria con fonoaudiología, actualmente sin disfagia, y con activación por kinesioterapia motora y respiratoria. Sin conflicto actual.

DIAGNOSTICOS EGRESO:

1. Crisis Hiperglicémica CAD/SHH severa, resuelta:

- Compromiso de conciencia resuelto

2. Sepsis Foco Abdominal + Respiratorio resuelto:

- Pancreatitis aguda etiología no precisada (Baltazar C)

- NAC Macroaspirativa por SAMS en manejo

- VMI (03-07/01)

3. AKI KDIGO II multifactorial resuelta

Antecedentes: DM2 NIR, PPVI en TARV (Dg 2011, inicia TARV en 2022, en controles en Hospital Clínico SBA, controles regulares con buena adherencia, (05/01/26), con CD4 43 y CV 68, log 1.83)

Diagnóstico de Egreso

DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON CETOACIDOSIS -
NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J: NO

Paciente en buenas condiciones generales, vigil, orientado en tiempo y espacio, HDE, afebril, sin requerimientos de O2 suplementario. En plan de alta a domicilio.

Plan Post Alta

INDICACIONES

Reposo Relativo

Regimen Diabetico Común

MEDICAMENTOS

Triumeq (Abacavir/Lamivudina/Dolutegravir) 1 comprimido al día VO

- Insulina NPH 36 unidades AM y 36 unidades PM vía subcutánea

- Insulina cristalina precomidas vía subcutánea según esquema:

menos de 120: nada

121-160: 10

161-200: 14

201-240: 18

241-280: 22

281 o más: 24

Enalapril 10 mg al día Vía Oral

CONTROLES:

Continuar manejo y controles de patologías crónicas habituales

Continuar control en infectología en Hospital Clínico SBA

Control en CDT con equipo de Diabetes, sollicitar hora con interconsulta.

En caso de síntomas y signos de alarma acudir a servicio de urgencia

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 12/01/2026 13:04

Página 3 de 4

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 12-01-2026 13:04:25

Página 4 de 4

INTERNO

Becado/Residente



Juan Opazo Cereceda

Médico Tratante (Staff)